

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5089993-57.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NANCI GRANDO

RECORRENTE: LEONARDO SILVA CALDAS

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

DIREITO À SAÚDE. RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. NEOPLASIA MALIGNA DO CÓLON. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LEI Nº 12.732/2012. PRAZO DE 60 DIAS ULTRAPASSADO. PRIMEIRO TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma da fundamentação supra. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2024.

5089993-57.2024.4.02.5101

510014965690 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5089993-57.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NANCI GRANDO

RECORRENTE: LEONARDO SILVA CALDAS

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Medida de Urgência interposto pelo demandante em face de decisão interlocutória exarada pelo d. Juízo Substituto da 28ª VF do Rio de Janeiro que, a seu turno, indeferiu a tutela provisória de urgência em que pretendia **consulta oncológica no prazo de 72 horas** [evento 4, DESPADEC1, autos de origem], em razão de diagnóstico de **neoplasia maligna do cólon**.

Pretende a reforma da decisão e a concessão da tutela porquanto estariam presentes os requisitos dispostos no art. 300 e seguintes do CPC. *In casu*, aduz a recorrente que a **probabilidade do direito** estaria amparada nos documentos anexos à inicial, em que se comprova que o diagnóstico do recorrente ocorreu há mais de 60 dias, de modo que já teria sido esgotado o prazo da Lei nº 12.732/2012. Já **risco ao resultado útil do processo** seria evidenciada pelo próprio quadro clínico desenhado pelos documentos médicos apresentados.

Deferimento da tutela recursal [evento 3, DESPADEC1].

Parecer do NAT-Jus [evento 14, PARECER1].

Sem contrarrazões pelas rés, em que pese devidamente intimadas.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A questão não suscita maior complexidade, porquanto enfrentada pela decisão monocrática que deferiu a liminar, cujas razões reproduzo em verdadeira hipótese de fundamentação *aliunde* ou *per relationem*:

"Em breve síntese, o demandante recebeu diagnóstico de neoplasia maligna de cólon esquerdo e foi operado com urgência por obstrução intestinal na data de 28/06/2024. Documento médico que acompanha a inicial nos autos de origem indica a "forte indicação de quimioterapia adjuvante

(curativa) por 6 meses", apontando a necessidade de início "o quanto antes devido alto risco de recidiva" e "podendo levar ao avanço da doença, com deterioração da saúde e risco de vida" [evento 1, ANEXO2, fl. 20].

Consta dos autos, ainda, parecer da CRLS [evento 1, ANEXO2, fls. 25/27], que confirma o quadro clínico do demandante e informando a sua inclusão no SER na data de 24 /07/2024, na posição 169ª da fila de espera.

Feitas estas considerações, não se pode olvidar que a Constituição Federal eleva o direito à saúde à categoria de garantia fundamental (art. 6º) de natureza prestacional, a que corresponde o dever de efetivação pelo Estado, por meio de políticas públicas levadas a cabo pela União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, caracterizando verdadeira competência comum (art. 23, II) e responsabilidade solidária, conforme reconhece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Tema 793 - STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesta linha de intelecção, a Lei 12.732/2012 dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo de 60 dias, a contar da confirmação do diagnóstico. Vejamos:

Art. 2º O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

§ 1º Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput , considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. (...)

Na espécie, como destacado anteriormente, há informação de que o demandante/recorrente recebeu diagnóstico de neoplasia maligna de cólon esquerdo e foi operado com urgência por obstrução intestinal na data de **28/06/2024** e sua inclusão no SER ocorreu em **24 /07/2024**.

Logo, mesmo que se considere como data de referência o dia 24/07/2024, o prazo de 60 dias estaria ultrapassado, o que, em conjunto à informação de risco de recidiva, é suficiente à demonstração da **probabilidade do direito** e do **periculum in mora**, na forma do art. 300 do CPC, a ensejar o deferimento da tutela.

Devo discordar do argumento suscitado pela decisão recorrida, no sentido de que o demandante já teria sido submetido a cirurgia de urgência para desobstrução intestinal, afastando a urgência.

A realização de cirurgia não afasta o quadro clínico de neoplasia maligna, garantindo ao demandante o direito consagrado pela Lei 12.732/2012, que, a seu turno, não faz distinção entre pacientes oncológicos, reversando a todos o direito ao primeiro tratamento em até 60 dias.

Por todo o exposto, entendo presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Federais, e **DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar às rés, em solidariedade, a realização de primeira consulta oncológica e o início do pertinente tratamento no prazo máximo de 72 horas**".

Posteriormente à decisão monocrática acima referenciada, foi anexado aos autos o parecer do NAT-Jus, que, em seu conteúdo, reforça a conclusão pelo deferimento da tutela, na medida em que reconhece a indicação do tratamento postulado e a urgência do quadro clínico do recorrente.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma da fundamentação supra. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.

5089993-57.2024.4.02.5101

510014907859 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5089993-57.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: LEONARDO SILVA CALDAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Medida de Urgência interposto pelo demandante em face de decisão interlocutória exarada pelo d. Juízo Substituto da 28ª VF do Rio de Janeiro que, a seu turno, indeferiu a tutela provisória de urgência em que pretendia **consulta oncológica no prazo de 72 horas** [evento 4, DESPADEC1, autos de origem], em razão de diagnóstico de **neoplasia maligna do cólon**.

Pretende a reforma da decisão e a concessão da tutela porquanto estariam presentes os requisitos dispostos no art. 300 e seguintes do CPC. *In casu*, aduz a recorrente que a **probabilidade do direito** estaria amparada nos documentos anexos à inicial, em que se comprova que o diagnóstico do recorrente ocorreu há mais de 60 dias, de modo que já teria sido esgotado o prazo da Lei nº 12.732/2012. Já **risco ao resultado útil do processo** seria evidenciada pelo próprio quadro clínico desenhado pelos documentos médicos apresentados.

Deferimento da tutela recursal [evento 3, DESPADEC1].

Parecer do NAT-Jus [evento 14, PARECER1].

Sem contrarrazões pelas rés, em que pese devidamente intimadas.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A questão não suscita maior complexidade, porquanto enfrentada pela decisão monocrática que deferiu a liminar, cujas razões reproduzo em verdadeira hipótese de fundamentação *aliunde* ou *per relationem*:

"Em breve síntese, o demandante recebeu diagnóstico de neoplasia maligna de cólon esquerdo e foi operado com urgência por obstrução intestinal na data de 28/06/2024. Documento médico que acompanha a inicial nos autos de origem indica a "forte indicação de quimioterapia adjuvante (curativa) por 6 meses", apontando a necessidade de início "o quanto antes devido alto risco de recidiva" e "podendo levar ao avanço da doença, com deterioração da saúde e risco de vida" [evento 1, ANEXO2, fl. 20].

Consta dos autos, ainda, parecer da CRLS [evento 1, ANEXO2, fls. 25/27], que confirma o quadro clínico do demandante e informando a sua inclusão no SER na data de 24 /07/2024, na posição 169ª da fila de espera.

Feitas estas considerações, não se pode olvidar que a Constituição Federal eleva o direito à saúde à categoria de garantia fundamental (art. 6º) de natureza prestacional, a que corresponde o dever de efetivação pelo Estado, por meio de políticas públicas levadas a cabo pela União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, caracterizando verdadeira competência comum (art. 23, II) e responsabilidade solidária, conforme reconhece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Tema 793 - STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesta linha de inteligência, a Lei 12.732/2012 dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo de 60 dias, a contar da confirmação do diagnóstico. Vejamos:

Art. 2º O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

§ 1º Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. (...)

*Na espécie, como destacado anteriormente, há informação de que o demandante/recorrente recebeu diagnóstico de neoplasia maligna de cólon esquerdo e foi operado com urgência por obstrução intestinal na data de **28/06/2024** e sua inclusão no SER ocorreu em **24 /07/2024**.*

*Logo, mesmo que se considere como data de referência o dia 24/07/2024, o prazo de 60 dias estaria ultrapassado, o que, em conjunto à informação de risco de recidiva, é suficiente à demonstração da **probabilidade do direito** e do **periculum in mora**, na forma do art. 300 do*

CPC, a ensejar o deferimento da tutela.

Devo discordar do argumento suscitado pela decisão recorrida, no sentido de que o demandante já teria sido submetido a cirurgia de urgência para desobstrução intestinal, afastando a urgência.

A realização de cirurgia não afasta o quadro clínico de neoplasia maligna, garantindo ao demandante o direito consagrado pela Lei 12.732/2012, que, a seu turno, não faz distinção entre pacientes oncológicos, reversando a todos o direito ao primeiro tratamento em até 60 dias.

*Por todo o exposto, entendo presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Federais, e **DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar às rés, em solidariedade, a realização de primeira consulta oncológica e o início do pertinente tratamento no prazo máximo de 72 horas**.*

Posteriormente à decisão monocrática acima referenciada, foi anexado aos autos o parecer do NAT-Jus, que, em seu conteúdo, reforça a conclusão pelo deferimento da tutela, na medida em que reconhece a indicação do tratamento postulado e a urgência do quadro clínico do recorrente.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma da fundamentação supra. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.